

CAPÍTULO 4.1

Valvulopatías Izquierdas

PERFIL EUNACOM 1.01.1.010
Dx: Específico • Tx: Inicial • Seg: Derivar

Las valvulopatías izquierdas son un tema fundamental en la cardiología del examen EUNACOM. Comprender su semiología no solo permite identificar la patología, sino también determinar su gravedad y las repercusiones hemodinámicas en el paciente. (ver Figura 4.1)

1. Semiología de los Soplos y Ruidos Cardíacos

El diagnóstico clínico de una valvulopatía comienza con la auscultación. Es vital distinguir el momento del ciclo cardíaco (sístole o diástole) y la alteración de los ruidos fundamentales (R1 y R2).

TABLA 4.1.1: VALVULOPATÍA VS TIPO DE SOPLO		
VALVULOPATÍA	TIPO DE SOPLO	ALTERACIÓN DE RUIDOS (R1/R2)
Estenosis Mitral (EM)	Diastólico (con refuerzo presistólico)	R1 aumentado (reforzado)
Insuficiencia Mitral (IM)	Holosistólico (o pansistólico)	R1 disminuido
Estenosis Aórtica (EA)	Sistólico eyectivo (mesosistólico)	R2 disminuido
Insuficiencia Aórtica (IA)	Diastólico	R2 disminuido

NOTA CLÍNICA
Fisiopatología de los ruidos: **R1:** Producido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares (Mitral y Tricúspide). **R2:** Producido por el cierre de las válvulas sigmoideas (Aórtica y Pulmonar). En general, la intensidad del ruido correspondiente a la válvula afectada **disminuye**, excepto en la **Estenosis Mitral**, donde el R1 se escucha más fuerte (reforzado) debido a la rigidez y la posición de los velos al inicio de la sístole.

2. Remodelación Cardíaca y Hallazgos en el EKG

Cada valvulopatía genera una sobrecarga distinta (de presión o de volumen), lo que determina qué cavidades se dilatan o hipertrofian.

Estenosis Mitral (EM)

Cardiomegalia: No suele haber dilatación del ventrículo izquierdo (VI), ya que este recibe poca sangre. Lo que se dilata masivamente es la **Aurícula Izquierda (AI)**. **EKG:** Signos de crecimiento de AI (onda P ancha o "P-mitrale"). **Complicación clave:** Es la causa más frecuente de **Fibrilación Auricular (FA)** valvular y tiene un alto riesgo de fenómenos embólicos.

Insuficiencia Mitral (IM)

Cardiomegalia: Existe dilatación tanto de la AI como del VI (sobrecarga de volumen). **EKG:** Signos de hipertrofia biventricular izquierda (AI y VI).

Estenosis Aórtica (EA)

Cardiomegalia: Inicialmente no hay cardiomegalia visible en la radiografía, pero existe una **hipertrofia concéntrica** del VI (el ventrículo lucha contra una obstrucción). **EKG:** Signos de hipertrofia ventricular izquierda (HVI). Con el tiempo, la rigidez del VI causa **disfunción diastólica** y **crecimiento secundario de la AI**.

Insuficiencia Aórtica (IA)

Cardiomegalia: Produce la dilatación más extrema de todas, conocida como **"Cor Bovis"** (corazón de vaca). **EKG:** Signos

marcados de HVI. La AI suele estar protegida por la válvula mitral si esta es competente.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Mnemotecnia para la Onda P: **P-Ancha:** Crecimiento de AI (Izquierda). "La pancha es de izquierda". **P-Alta (Picuda):** Crecimiento de AD (Derecha). "La paltona es de derecha".

3. Clínica Específica y Perlas Diagnósticas

Estenosis Mitral

Facies Mitralica (Chapetas): Coloración violácea/morada en las mejillas. **Hemoptisis:** Por ruptura de venas bronquiales debido a la hipertensión venocapilar pulmonar. **Refuerzo presistólico:** Se produce por la contracción auricular al final de la diástole.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si un paciente con Estenosis Mitral entra en **Fibrilación Auricular**, desaparecen tres hallazgos semiológicos: 1. El refuerzo presistólico del soplo. 2. El cuarto ruido (R4). 3. La onda "a" del pulso venoso yugular.

Insuficiencia Mitral

El soplo se ausculta mejor en el **ápex** e irradia frecuentemente a la axila. Puede presentar un **R3** si existe disfunción sistólica o flujo rápido excesivo. **Diagnóstico diferencial:** Si los velos se ven sanos en el ecocardiograma, la insuficiencia suele ser funcional (secundaria a una miocardiopatía dilatada que estiró el anillo valvular).

Estenosis Aórtica

Se caracteriza por la tríada de: **Angina, Síncope (de esfuerzo) y Disnea (Insuficiencia Cardíaca)**. **Pulso:** Parvus et tardus (pequeño y lento).

TABLA 4.1.2: DIFERENCIA VS ESTENOSIS AÓRTICA		
DIFERENCIA	ESTENOSIS AÓRTICA	MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA OBSTRUCTIVA
Pulso	Parvus et tardus	Seller (amplio/rápido)
Maniobra de Valsalva	Disminuye el soplo	Aumenta el soplo
Posición en Cuclillas	Aumenta el soplo	Disminuye el soplo

Insuficiencia Aórtica

Es la valvulopatía de los "signos periféricos" debido al gran volumen sistólico y la caída rápida de la presión diastólica. **Pulso:** Seller o en "martillo de agua" (amplio y colapsante). **Danza arterial:** Pulsaciones visibles en las arterias del cuello (carótidas).

4. Síntomas Comunes

Independiente de la válvula afectada, todas las valvulopatías izquierdas terminan produciendo síntomas de **Insuficiencia Cardíaca** de predominio izquierdo por congestión retrógrada: - Disnea de esfuerzo. - Disnea paroxística nocturna (DPN). - Ortopnea. - Edema pulmonar agudo en casos severos.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el EUNACOM, ante un paciente con **soplo diastólico** y **FA**, piensa inmediatamente en **Estenosis Mitral**. Si el paciente tiene **síncope de esfuerzo** y **soplo sistólico**, la respuesta suele ser **Estenosis Aórtica**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

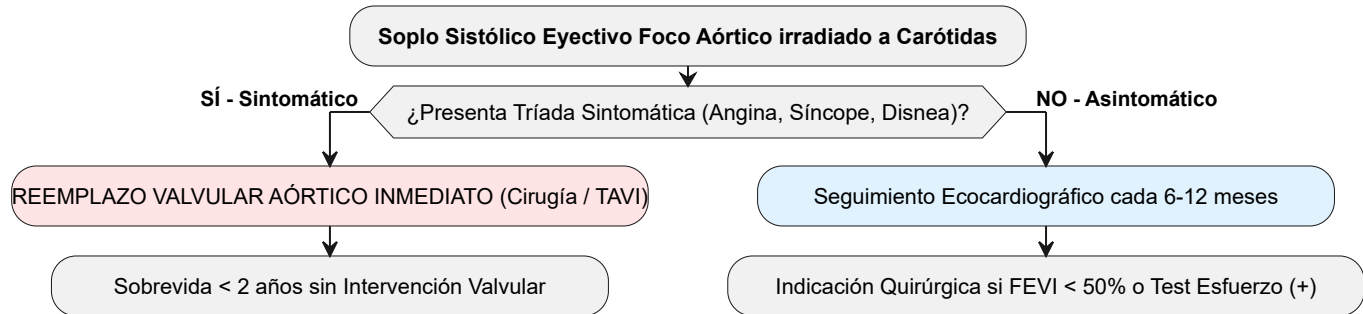
"Hombre de 76 años consulta por síncope de esfuerzo y angina. Auscultación: soplo sistólico eyectivo áspero en foco aórtico irradiado a carótidas con pulso parvus et tardus."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

La Estenosis Aórtica Severa senil se manifiesta por la tríada: Angina, Síncope y Disnea de esfuerzo. Al examen destaca soplo sistólico eyectivo irradiado a carótidas, A2 disminuido y pulso parvus et tardus. Una vez sintomática, la sobrevida es <2-3 años sin tratamiento; la indicación definitiva es el Reemplazo Valvular Aórtico (quirúrgico o TAVI).

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente en adultos mayores de países desarrollados
- La tríada clásica de estenosis aórtica es angina, síncope y disnea
- EA severa: área < 1 cm², gradiente medio > 40 mmHg, velocidad máxima > 4 m/s
- La estenosis mitral es casi exclusivamente de origen reumático
- La insuficiencia mitral es la valvulopatía más prevalente globalmente
- La insuficiencia aórtica crónica genera los signos periféricos de amplia presión diferencial
- TAVI es alternativa al reemplazo quirúrgico en EA severa de alto riesgo
- La reparación mitral es preferida sobre el reemplazo en insuficiencia mitral

FIGURA 4.1: ALGORITMO DE ESTENOSIS AÓRTICA SEVERA E INDICACIÓN QUIRÚRGICA

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (VALVULOPATÍAS IZQUIERDAS)**PREGUNTA 1**

Valvulopatías Izquierdas

- A)** Manejo médico con betabloqueadores
- B)** Valvuloplastia aórtica con balón como tratamiento definitivo
- C)** Reemplazo valvular aórtico quirúrgico o TAVI
- D)** Seguimiento ecocardiográfico cada 6 meses
- E)** Inicio de vasodilatadores arteriales

PREGUNTA 2

Valvulopatías Izquierdas

- A)** Insuficiencia mitral severa
- B)** Estenosis aórtica
- C)** Estenosis mitral
- D)** Prolapso de válvula mitral
- E)** Insuficiencia aórtica

PREGUNTA 3

Valvulopatías Izquierdas

- A)** Enfermedad reumática
- B)** Endocarditis infecciosa
- C)** Enfermedad mixomatosa con prolapso mitral
- D)** Isquemia miocárdica
- E)** Miocardiopatía dilatada

RESUMEN EJECUTIVO: VALVULOPATÍAS IZQUIERDAS

Las valvulopatías izquierdas comprenden las lesiones de la válvula aórtica (estenosis e insuficiencia) y la válvula mitral (estenosis e insuficiencia). La estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente en adultos mayores de países desarrollados, causada principalmente por degeneración calcificada. La estenosis mitral es casi exclusivamente de origen reumático. La insuficiencia mitral es la valvulopatía más prevalente a nivel global. El diagnóstico se basa en la auscultación característica y se confirma con ecocardiograma transtorácico. La estenosis aórtica produce un soplo sistólico eyectivo en foco aórtico con irradiación a carótidas, se clasifica como severa con área valvular menor a 1 cm² y gradiente medio mayor a 40 mmHg. La estenosis mitral produce un soplo diastólico con chasquido de apertura en el ápex. La insuficiencia mitral produce un soplo holosistólico en el ápex con irradiación axilar. La insuficiencia aórtica produce un soplo diastólico aspirativo en foco aórtico. El tratamiento de la estenosis aórtica severa sintomática es el reemplazo valvular quirúrgico o TAVI. La estenosis mitral severa sintomática se trata con valvuloplastia mitral percutánea si la anatomía es favorable. La insuficiencia mitral severa se trata preferentemente con reparación quirúrgica. La insuficiencia aórtica severa requiere reemplazo valvular cuando hay síntomas o disfunción ventricular.